

Tema 5: Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus Tipo 2 e Hipotensión Ortostática.

1. Introducción y relevancia clínica

Las enfermedades cardiometabólicas son altamente prevalentes en personas mayores y constituyen una de las principales causas de discapacidad, pérdida de autonomía, hospitalizaciones, mortalidad.

Sin embargo, **el objetivo terapéutico en geriatría no es sólo controlar cifras o parámetros de laboratorio, sino preservar funcionalidad y calidad de vida.**

En el adulto mayor, la pregunta clave no es solo “**¿Cuál es la presión / glicemia?**”, sino “**¿Cómo está su función, marcha, memoria y autonomía?**”

Esto cambia profundamente el abordaje clínico, especialmente en:

- Metas terapéuticas,
 - Elección de fármacos,
 - Riesgos adversos,
 - Toma de decisiones compartidas.
-

2. Fisiopatología y bases conceptuales

2.1 Cambios del envejecimiento relevantes

- Menor elasticidad vascular → mayor **rigidez arterial** → **HTA sistólica**.
- Disminución de masa y fuerza muscular → **insulinorresistencia** → DM2.
- Disminución de barorreflejos y control autonómico → **hipotensión ortostática**.
- Mayor riesgo de **efectos adversos farmacológicos** por:
 - menor filtración renal,
 - menor metabolismo hepático,
 - mayor sensibilidad del SNC.

La suma de estos factores aumenta el riesgo de:

- Caídas,
- Delirium,
- Hipoglicemia,
- Lesión renal aguda.
-

Por eso la **“intensidad terapéutica”** debe individualizarse.

A) Hipertensión Arterial en el Adulto Mayor

3. Clínica y diagnóstico

La HTA del mayor suele ser:

- **sistólica predominante**, por rigidez arterial,
- muchas veces **asintomática**.

Se debe **confirmar diagnóstico con medición repetida** y/o **AMPA/MAPA**, tal como en población general.

Objetivo adicional: evaluar **daño de órgano blanco**:

- HVI en ECG/eco,
 - proteinuria o microalbuminuria,
 - retinopatía.
-

4. Tratamiento (enfocado en adulto mayor)

Metas terapéuticas orientadas a funcionalidad

- **65–79 años:** PA objetivo 130–139 / 70–79 mmHg.
- **>80 años:** tratar si PA sistólica ≥ 160 mmHg, buscar objetivo 140–150 mmHg si bien tolerado.

Evitar descensos bruscos → riesgo de delirium, síncope y caídas.

Primera línea

- IECA o ARA II (losartán común en APS en Chile).
- Calcioantagonistas (amlodipino).
- Diuréticos tiazídicos (clortalidona preferida).

Consideraciones geriátricas

- Preferir **dosis bajas y aumentos lentos**.
- Vigilar **creatinina y potasio** con IECA/ARA II.

- Evitar **betabloqueadores** si no hay indicación clara (IC, arritmia).
-

B) Diabetes Mellitus Tipo 2 en el Mayor

3. Clínica y diagnóstico

La presentación puede ser **pobre en síntomas**:

- cansancio, baja de peso, infecciones urinarias recurrentes,
- declinación funcional o cognitiva.

Objetivo principal: prevenir **hipoglicemia**, pues:

- precipita **caídas**,
 - genera **delirium**,
 - empeora **fragilidad**.
-

4. Metas de control según funcionalidad

Situación funcional	Meta HbA1c	Racional
Mayor robusto	7–7.5%	Buen pronóstico, más beneficios a largo plazo
Pre-frágil o múltiples comorbilidades	7.5–8%	Equilibrar beneficios y riesgos
Frágil o con demencia	8–8.5%	Minimizar riesgo de hipoglicemia y pérdida funcional

NO buscar HbA1c <7% en mayores frágiles.

Esto es un **error frecuente** en EUNACOM.

5. Tratamiento farmacológico (en personas mayores)

Fármaco	Ventajas	Precauciones
Metformina	Primera línea, seguro, económico	Suspender si TFG <30 o riesgo de deshidratación

Fármaco	Ventajas	Precauciones
iDPP-4 (sitagliptina)	Bajo riesgo de hipoglicemia	Buena opción en frágiles
Insulina	Útil si falla terapia oral	Evitar esquemas complejos; preferir basal sola

Evitar sulfonilureas (glibenclamida) → alto riesgo de **hipoglicemia y caídas**.

C) Hipotensión Ortostática

3. Clínica

Se define como **descenso de PA ≥ 20 mmHg sistólica o ≥ 10 mmHg diastólica** dentro de 3 minutos tras ponerse de pie.

Síntomas:

- Mareos.
- Visión borrosa.
- Inestabilidad.
- Síncope.
- **Caídas.**

Común en:

- Deshidratación.
- Polifarmacia (antihipertensivos, diuréticos, antidepresivos).
- Neuropatías autonómicas (diabetes).

4. Diagnóstico

Medir PA:

1. en decúbito 5 minutos,
2. repetir de pie al minuto y a los 3 minutos.

Evaluar:

- hidratación,

- hemoglobina,
- fármacos,
- función renal.

5. Tratamiento

No farmacológico (primera línea):

- Aumentar hidratación y sal si no contraindicado.
- Evitar levantarse bruscamente.
- Medias compresivas.
- Elevación cabecera cama.
- Ejercicio de pantorrilla antes de levantarse.

Farmacológico (si persistente):

- **Midodrina** (si PA basal lo permite).
- **Fludrocortisona** (con control estrecho de edema y potasio).

Ajustar antihipertensivos antes de iniciar fármacos estimulantes.

6. Complicaciones y pronóstico

Condición	Riesgos principales
HTA	ACV, IC, ERC si no tratada
DM2	Caídas, neuropatía, nefropatía, demencia si mal controlada
Hipotensión ortostática	Caídas, fracturas, delirium, hospitalización

En todos los casos, **el deterioro funcional es el principal desenlace a prevenir.**

7. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM

Perlas

- En mayores, **evitar “sobret ratamiento”** es tan importante como evitar el “no tratamiento”.
- **Hipoglicemia = emergencia geriátrica** aunque la glicemia no sea extremadamente baja.
- En HTA sistólica aislada, los **calcioantagonistas** funcionan mejor.
- La **hipotensión ortostática** no es un síntoma menor; se asocia directamente a caídas.

Errores frecuentes

- Buscar HbA1c <7% en una persona frágil.
 - Mantener sulfonilureas por costumbre.
 - Aumentar antihipertensivos sin evaluar ortostatismo.
 - No preguntar por **caídas** al ajustar fármacos.
-

8. Resumen final (5–7 ideas clave)

1. En geriatría, el objetivo no es “normalizar parámetros”, sino **preservar funcionalidad**.
2. HTA: metas más amplias y ajustes lentos para evitar **hipotensión y caídas**.
3. DM2: la **hipoglicemia es más peligrosa que la hiperglicemia** en mayores.
4. HbA1c se ajusta según **estado funcional**, no edad.
5. Evitar sulfonilureas; privilegiar metformina e iDPP-4.
6. La hipotensión ortostática debe **buscarse activamente** y tiene manejo estructurado.
7. El ejercicio, la nutrición y la revisión farmacológica siguen siendo pilares transversales.